



SAFE
INTERNATO

GUIA PRÁTICO

PRESCRIÇÃO HOSPITALAR

Do primeiro plantão ao raciocínio de UTI — tudo que você vai usar na prática.

9

MÓDULOS

12+

ATBS C/ DILUIÇÃO

7

PROTOCOLOS
ELETRÓLITOS

100%

APLICÁVEL NO DIA
1

SOBRE ESTE GUIA

POR QUE VOCÊ PRECISA DISSO?

Você chega no seu primeiro plantão. O residente te olha e diz: "**prescreve aí.**" E aí trava. Não porque você não estudou — mas porque ninguém, em nenhuma aula, em nenhum livro, te ensinou como estruturar uma prescrição segura do zero. **Esse é o gap que o Safe Internato veio resolver.**

24 ERROS

de prescrição para cada 1.000 pacientes/dia

A maioria é evitável. E começa exatamente onde este guia atua — na estrutura, no critério e na segurança de cada item que você escreve.

O QUE VOCÊ ENCONTRA DENTRO

CHECKLIST DOS 9 ITENS

Com o FAST HUG como guia, você nunca mais esquece um item essencial — da dieta aos cuidados específicos.

ATB EMPÍRICO POR FOCO

Tabela pronta: pulmonar, urinário, abdominal, pele e corrente sanguínea. Comunitária vs. hospitalar. Tempo de tratamento.

DILUIÇÃO DE 12 ANTIBIÓTICOS

Apresentação, volume e tempo de infusão de Ceftriaxona, Vancomicina, Imipenem, Pip-Tazo, Cefepime e mais.

7 DISTÚRBIOS ELETROLÍTICOS

Fórmulas, doses, velocidade de correção e limites de segurança. Hiponatremia, Hipercalemia, Magnésio, Cálcio e mais.

PROFILAXIAS COM CRITÉRIO

Quando usar omeprazol de verdade. Escore de Padua. Dose certa de heparina por peso.

CONTROLE GLICÊMICO

Basal-bolus, fator de correção 1:40, HbA1c na admissão, manejo de hipo e hiperglicemia.

PARA QUEM É ESTE GUIA

- **Interno do 5º e 6º ano** que precisa de referência rápida e confiável no dia a dia.
- **R1 nos primeiros meses**, consolidando a base antes de protocolos mais complexos.
- **Estudante** que quer entender a medicina real antes de chegar no hospital.
- **Plantonista** que precisa de consulta rápida às 2h, quando o eletrólito altera.

ORIENTAÇÕES INICIAIS DE PRESCRIÇÃO

A prescrição é a transcrição do seu planejamento terapêutico. Dados estimam **24 erros para cada 1.000 pacientes/dia** — um ponto muito negligenciado nos currículos.

PASSOS ESSENCIAIS DA PRESCRIÇÃO

1

SEGURANÇA DO PACIENTE

Correta identificação · data · hora.

2

MEDICAÇÕES E CUIDADOS

Uso da ferramenta FAST HUG.

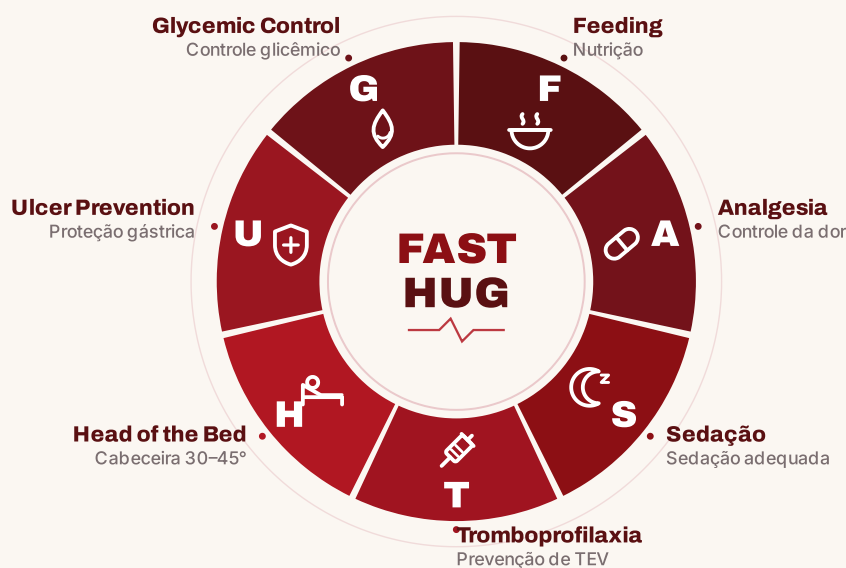
3

SEGURANÇA DO PROFISSIONAL

Identificação — sem recomendação formal de carimbo.

FERRAMENTA FAST HUG

Mnemônico que guia racionalmente os cuidados na hora de prescrever cada paciente — sete itens, um por segmento.



Na prática: outros mnemônicos também utilizados — DEVO e DDVI.

CHECKLIST DE PRESCRIÇÃO

Os **9 itens** que toda prescrição precisa ter — sem exceção. Use como roteiro mental antes de assinar.

01

Dieta

Via preferencial, consistência e tipo terapêutico.

02

Hidratação

Apenas para desidratados — nunca de rotina.

03

Antibióticos

Foco + dia do ATB (ex: D3/7) + diluição obrigatória.

04

Profilaxias

Úlcera de estresse + trombopprofilaxia.

05

Sintomáticos

Dor, náusea, insulina — com cuidados específicos por item.

06

Controle glicêmico

HbA1c na admissão de todo diabético ou glicemia > 140.

07

Medicamentos de uso contínuo

Anti-HAS, antiepiléticos, insulinas de horário, anticoagulantes.

08

Cuidados gerais

Fisioterapia, peso diário em jejum, diurese quando indicado.

09

Cuidados específicos

Individualizado para o quadro clínico de cada paciente.

DIETA E HIDRATAÇÃO

DIETA

- A via preferencial de nutrição é a enteral via oral.
- **Consistência:** líquida · pastosa · leve · branda · geral.
- **Dietas terapêuticas:** normo/hipo/hipercalórica · normo/hipo/hiperproteica · hipogordurosa · assódica/hipossódica · sem resíduos · laxativa · diabetes · hipocalêmica · hipofosfatêmica.



JEJUM — avaliar nos seguintes casos: rebaixamento do nível de consciência · hemorragia digestiva · vômitos refratários por neoplasia de TGI · noradrenalina > 0,5 mcg/kg/min · exame contrastado.

EM JEJUM — APORTE GLICÊMICO OBRIGATÓRIO

- **Dose:** 2 g/kg de glicose 50% em 24h.

Exemplo (80 kg): 160 g = 32 amp G50% (5 g/10 mL). Sem restrição hídrica: SF 0,9% 420 mL + glicose 50% 8 amp, EV, 6/6h.

- **Dieta por SNE:** meta 25–30 kcal/kg/dia · dieta 1,2–1,5 kcal/mL · pausar das 22h às 6h · preferir água livre pela sonda.

HIDRATAÇÃO

- Indicada **APENAS para desidratados** — não prescrever de rotina.



IC descompensada ou LRA oligoanúrica com hipervolemia: RESTRINGIR hidratação a 800 mL/dia — não hidratar.

EM UMA FRASE

Hidratação não é item de rotina: é conduta com indicação — e com limite.

ANTIBIOTICOTERAPIA

Princípios gerais, classes disponíveis, diluições e guia empírico por foco.

PRINCÍPIOS GERAIS

- No 1º dia: **dose habitual**; corrigir para função renal após 24h.
- **Discriminar o dia do ATB** — ex: D3/7.
- Iniciar **empiricamente pelo foco**; guiar por cultura quando disponível.
- **Ciclos curtos** cada vez mais recomendados com melhora clínica.



Diluições — atenção: Ceftriaxona: água destilada · Vancomicina: 1 g em SF 0,9% 250 mL · Demais: ~100 mL SF 0,9%.

CLASSES DISPONÍVEIS

CLASSE	ANTIBIÓTICOS
Beta-lactâmicos — Penicilinas	Penicilina G (Benzatina), Oxacilina, Ampicilina, Amoxicilina
Beta-lactâmicos — Carbapenêmicos	Imipenem
Inibidores de beta-lactamase	Amoxicilina-Clavulanato, Piperacilina-Tazobactam
Cefalosporinas	1ª gen: Cefalexina (oral) · 3ª gen: Ceftriaxona (EV) · 4ª gen: Cefepime (EV)
Macrolídeos	Azitromicina, Claritromicina
Quinolonas	3ª gen: Ciprofloxacino · Respiratória: Levofloxacino
Lincosamidas	Clindamicina
Derivados da sulfá / Outros	Sulfametoxazol, Sulfadiazina, Metronidazol, Vancomicina

APRESENTAÇÃO E DILUIÇÃO

ANTIBIÓTICO	APRESENTAÇÃO	DILUIÇÃO	TEMPO
Benzilpenicilina Potássica	5.000.000 U	50–200 mL SF/SGI	60–120 min
Oxacilina	500 mg pó estéril	50–100 mL SF/SGI	3h
Imipenem + Cilastatina	500 mg liofilizado	100 mL SF	2h
Piperacilina + Tazobactam	4,5 g pó estéril	50–150 mL SF/SGI	4h
Ceftriaxona	1 g liofilizado	50–100 mL SF/SGI	30 min
Cefepime	1 g pó estéril	50–100 mL SF/SGI	3h
Ciprofloxacino	200 mg/100 mL	Sem reconstituição	60 min
Claritromicina	500 mg + 10 mL ABD	250 mL SF/SGI	60 min
Clindamicina	600 mg/4 mL	300 mg em 50 mL SF/SGI	30 min
Metronidazol	500 mg/100 mL	Sem reconstituição	60 min
Vancomicina	500 mg liofilizado	500 mg → 100 mL / 1 g → 200 mL	60 min

GUIA EMPÍRICO POR FOCO

FOCO	INFECÇÃO COMUNITÁRIA	ASSOCIADA À SAÚDE	TEMPO
PULMONAR	Ceftriaxona 1g 12/12h + Azitromicina 500mg/dia · Opção: Levofloxacino 750mg/dia · DPOC: Cefepime · PNM aspirativa: + Clindamicina	Piperacilina-Tazobactam · Prévio cefalo/quinolona: Imipenem	5–7 dias
URINÁRIO	Ceftriaxona · Opção: Ciprofloxacino	Cefepime ou Imipenem	5–7 dias
ABDOMINAL	Ceftriaxona + Metronidazol	Cefepime ou Imipenem (+ Metronidazol se Cefepime)	5–7 dias
PELE / PPM	Cefalexina ou Oxacilina · Necrose: + Clindamicina	Cefepime + Vancomicina	7–10 dias
CORRENTE SANGÜÍNEA	—	Imipenem + Vancomicina · ou Pip-Tazo + Vancomicina	7–10 dias
SEM FOCO	Ceftriaxona	Pip-Tazo + Vancomicina	7–10 dias

PROFILAXIAS

ÚLCERA GÁSTRICA POR ESTRESSE

Ulceração no TGI secundária à hospitalização. Regra na enfermaria: **NÃO prescrever de rotina.**

Avaliar prescrição apenas nos seguintes casos:

- ☐ Uso de altas doses de corticoide ≥ 1 mg/kg.
- ☐ Uso de anticoagulantes ou antiplaquetários.
- ☐ Uso de AINEs.

Dose: Omeprazol 40 mg VO 1x/dia. Via EV **somente** em pacientes em ventilação mecânica.

TROMBOPROFILAXIA — TEV

- ☐ Indicada apenas para pacientes com **mobilidade reduzida** na internação.
- ☐ Usar **Escore de PADUA** — pontuação ≥ 4 : benefício em receber profilaxia.



JAMAIS realizar em pacientes com sangramento ativo.

HBPM reservada para anticoagulação plena. Para profilaxia, usar HNF:

< 70 kg

Heparina NF 5000 UI/0,25 mL
01 amp SC 12/12h

> 70 kg

Heparina NF 5000 UI/0,25 mL
01 amp SC 8/8h

MEDICAMENTOS CONTÍNUOS E SINTOMÁTICOS

MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO

Ex: anti-hipertensivos, antiepilépticos, ansiolíticos, insulinas NPH e regular de horário, anticoagulantes.

- **Diuréticos EV:** evitar doses noturnas → risco de noctúria e quedas. Sugerir 8h e 14h.
- **Diabéticos:** suspender metformina → iniciar esquema basal-bolus de insulinização.
- **Medicamento ausente na farmácia, mas com o paciente:** prescrever + "(com o paciente)".

SINTOMÁTICOS

DOR

- Checar alergia a dipirona ou paracetamol.
- DRC ou úlcera gástrica: evitar AINE de horário — preferir opioide.

NÁUSEAS E VÔMITOS

- Checar síndrome extrapiramidal prévia com procinéticos.
- **NUNCA utilizar procinéticos em pacientes com neoplasia do TGI.**

CORREÇÃO DE INSULINA

- **HbA1c na admissão:** todos os diabéticos e glicemia capilar > 140 mg/dL.
- **Glicemia capilar 6/6h:** jejum, DM não controlada, pacientes graves.

HIPERGLICEMIA

Fator de correção **1:40** · corrigir apenas glicemias pré-prandiais · **NUNCA corrigir após as 22h.**

HIPOGLICEMIA

Glicemia capilar **< 70 mg/dL:** 3 amp G50% (15 g) VO se acordado · EV se sonolento.

CUIDADOS ADICIONAIS

- Quantificar diurese · peso diário em jejum · fisioterapia respiratória e motora — **quando indicado.**

ATENÇÃO

ERROS PARA NUNCA COMETER

Vícios de prescrição mais comuns — e mais evitáveis. Grave estes quatro.

1

Diurético + hidratação juntos

Evite prescrever diurético e hidratação na mesma prescrição.

2

Anti-hipertensivo condicional à PA

Jamais. Pressão alta por dor? Trate a causa. Hipertenso recebe medicamento de horário; se elevar em 24h, associe outro.

3

Omeprazol EV para todos

Jamais — via EV apenas para HDA (hemorragia digestiva alta).

4

Corticoide rotineiro em toda pneumonia

Evite. E oxigênio: não prescrever "X L/min se SatO2 < Y" — tatear dose e prescrever fisioterapia para desmame.

LEMBRE

Conduta segura começa com a pergunta certa — não com o reflexo automático.

CORREÇÃO DE ELETRÓLITOS

Protocolos práticos para os 7 principais distúrbios hidroeletrólíticos.

1 HIPONATREMIA $\text{Na} < 120 \text{ mEq/L}$ com sintomas graves

Fórmula de Adrogue-Madias: $\Delta[\text{Na}] \text{ solução} - \Delta[\text{Na}] \text{ paciente (L)} / \text{Água corporal} + 1$

Água corporal: adulto σ $0,6 \times \text{peso}$ | φ $0,5 \times \text{peso}$ · idoso σ $0,5 \times \text{peso}$ | φ $0,45 \times \text{peso}$ · **Variação segura:** 8–10 mEq/L em 24h

- ☐ **Hipovolemia:** SF 0,9% · **Sintomas graves:** NaCl 3% (110 mL NaCl 10% + 390 mL SF 0,9%).
- ☐ Monitorar Na a cada 6h (graves). Agudos em condição ideal: gasometria a cada 20 min.

2 HIPERNATREMIA $\text{Na} > 150 \text{ mEq/L}$ com sintomas

Déficit de água livre: $\text{peso} \times 0,6 \times [(\text{Na sérico} / 140) - 1]$

Variação do Na c/ 1L hipotônico: $(\text{Na solução} - \text{Na sérico}) / (\text{H}_2\text{O corporal} + 1)$

NaCl 0,45% = 23 mL NaCl 10% + 477 mL NaCl 0,9% = 77 mEq/L · **Variação segura:** 10 mEq/L em 24h

- ☐ **Hipovolemia:** SF 0,9% · **Euvolêmico:** SG 5% EV · **VO:** água mineral.

3 HIPOCALEMIA $\text{K} < 3,5 \text{ mEq/L}$

- ☐ **Periférico calibroso:** KCl 10% 2 amp em 250 mL SF 0,9% EV — BIC em 3h.
- ☐ **Acesso central:** KCl 10% 3 amp em 250 mL SF 0,9% EV — BIC em 4h.

4 HIPERCALEMIA $\text{K} > 6,0 \text{ mEq/L}$

- ☒ **Alteração no ECG:** Gluconato de Cálcio 10% 1–2 amp (1–2 g) em 100 mL SF 0,9%, EV, 10–20 min — até reversão das alterações.

CORREÇÃO DE ELETRÓLITOS

Hipercalcemia — condutas (cont.)

Depleção de K:

- Furosemida 1 mg/kg EV (amp 10 mg/mL). Manter 6–8h se necessário.

Shift intracelular:

- **Solução polarizante:** Insulina Regular 10 UI em 100 mL SG 50%, EV, 30–60 min. Repetir 6h.
- **Beta-2 agonista:** fenoterol 10–20 gotas em 5 mL SF 0,9% nebulização. Repetir 4h.
- **Bicarbonato de Sódio 8,4%** 1 mEq/kg — APENAS se acidose metabólica associada.

5

HIPOMAGNESEMIA Mg < 1,7 mg/dL

- **Grave (< 1 mg/dL) — ataque:** MgSO₄ 10% 1–2 amp (1–2 g) em 50–100 mL SG 5% EV — 30–60 min.
- **Manutenção:** MgSO₄ 10% 4–8 amp (4–8 g) em 500 mL SG 5% EV — 12–24h em BIC.
- **Assintomático (1–1,5 mg/dL):** MgSO₄ 10% 2–4 amp em 500 mL SG 5% — BIC em 4h.

6

HIPOCALCEMIA Cálcio iônico < 1,0 mmol/L

- **Ataque:** Gluconato de Cálcio 10% 2 amp (2 g) + SF 0,9% 100 mL EV — 20–30 min.
- **Manutenção:** Gluconato de Cálcio 10% 10 amp (10 g) + 900 mL SF 0,9%, EV, em 24h.

7

HIPERCALCEMIA Cálcio iônico > 1,5 mmol/L

- **Hidratação vigorosa:** SF 0,9% 4–6 L em 24h.
- **Bifosfonatos:** Pamidronato 60–90 mg + SF 0,9% 250 mL EV em 4h (se disponível).

Sobrecarga hídrica: Furosemida EV · **Disfunção renal grave:** avaliar hemodiálise.



SAFE INTERNATO

Medicina de alta performance — prática, humana e
tecnológica.

Tudo em um só lugar para o interno.

MEDSAFEBRASIL.COM.BR/EDUCATION